

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional San Rafael
Ingeniería en Sistemas de Información

Formulación inicial del proyecto

Tp 1 - Clínica del sur



Integrantes: Lepez Joaquín - Geyer Juan Jose - Lopez Juan - Sorato Emiliano
Profesor: Juan Gijón
Marzo 2026

1. Nombre tentativo del proyecto

Sistema de gestión de agenda y notificaciones automatizadas.

2. Síntesis breve del proyecto

Para este caso se propone la implementación de una solución digital centralizada que asigne turnos médicos, reemplazando el registro manual y descentralizado actual. La solución permitirá la gestión en tiempo real de las agendas de los profesionales y el envío automático de recordatorios de turnos por canales digitales con el objetivo de reducir el ausentismo y la superposición de turnos, optimizando el trabajo del personal administrativo.

3. Canvas inicial del proyecto

3.1 Propuesta de valor

¿Qué valor aportaría el proyecto a la organización y/o a los usuarios?

Mejora del proceso administrativo mediante la centralización de turnos y envío de recordatorios automáticos. Esto reducirá la superposición de turnos, reclamos de los pacientes y el ausentismo mejorando la experiencia tanto para pacientes como para trabajadores.

3.2 Segmentos o destinatarios principales

¿Quiénes son los principales usuarios, beneficiarios o destinatarios?

El personal administrativo, el cuerpo médico de la clínica y los pacientes de la institución.

3.3 Canales

¿Por qué medios llegaría la solución a los usuarios?

Aplicación web para administración interna y servicios de mensajería (WhatsApp, SMS o Email) para comunicación con pacientes.

3.4 Relación con los usuarios

¿Cómo se espera interactuar con los usuarios o acompañarlos en el uso?

Habrà una capacitación inicial al personal y un soporte post-implementación para

aclarar dudas. Los pacientes deben ser informados por el personal sobre el nuevo sistema.

3.5 Actividades clave

¿Cuáles serían las actividades principales necesarias para llevar adelante el proyecto?

Creación de la plataforma, diseño de horarios por cada médico y capacitación al personal administrativo.

3.6 Recursos clave

¿Qué recursos serían necesarios para implementar el proyecto?

Infraestructura informática básica (computadoras e Internet), software que se utilizará (puede ser uno existente o crear uno simple a la medida) y personal administrativo capacitado.

3.7 Socios o actores clave

¿Qué actores externos o internos son clave para la ejecución?

Dirección de la Clínica (patrocinador) y personal dispuesto a ayudar.

3.8 Costos principales

¿Qué tipos de costos podrían aparecer en una primera aproximación?

Pago de licencia de un software o horas de desarrollo del mismo, costo de envío de mensajes y tiempo invertido en capacitación.

3.9 Beneficios o resultados esperados

¿Qué mejoras, beneficios o resultados se esperan obtener?

Disminución de sobrecarga administrativa, reducción de reclamos por turnos y reducción de ausentismo.

4. Alcance preliminar del proyecto

4.1 Objetivo del proyecto

¿Qué se busca lograr con este proyecto?

Implementar una solución digital para la gestión de agendas y notificación de turnos en el plazo de un mes, logrando eliminar el 100% de las superposiciones de turnos y reduciendo el ausentismo de pacientes mediante notificaciones automáticas.

4.2 Incluye

¿Qué elementos o funcionalidades quedarían dentro del proyecto?

Gestión de agenda médica (creación, eliminación y modificación de turnos).
Sistema de envío automático de recordatorios de turnos (24 hs antes de la cita)
Dashboard con indicadores clave como ausentismo y ocupación de turnos.

4.3 No incluye

¿Qué aspectos quedan explícitamente fuera del proyecto en esta primera etapa?

Manejo de historias clínicas electrónicas.
Facturación, cobros o gestión de obras sociales.

4.4 Entregables principales

¿Cuáles serían los entregables más importantes del proyecto?

Software funcional integrado con la infraestructura de la clínica.
Manual de usuario para los operadores del sistema.

5. Stakeholders

Stakeholder / actor	Rol o vínculo con el proyecto	Interés (alto/medio/bajo)	Influencia (alta/media/baja)
Personal	Usuario principal y operador	Alto	Medio
Junta médica	Usuario, aprueba requerimientos	Bajo	Alto
Pacientes mayores	Detractor, usuario final	Media	Baja
Dirección de la Clínica	Patrocinador, toma de decisiones	Alto	Alta

Análisis breve

Los stakeholders más críticos son la Dirección de la Clínica y el Personal Administrativo. La Dirección es crítica porque su apoyo (patrocinio) es esencial para la aprobación, asignación de recursos y ejecución del proyecto. Sin su alta influencia, el proyecto no avanza. El Personal Administrativo es crítico porque son los usuarios principales y operadores directos del sistema; su alta resistencia al cambio o falta de capacitación podría sabotear la implementación, a pesar de tener

una influencia media, su interés es alto y son la clave para la adopción exitosa y el funcionamiento diario. La Junta Médica también es crítica debido a su alta influencia en la definición de las agendas y requerimientos médicos.

6. KPI base

KPI	Qué mide	Cómo podría observarse o calcularse
% Cancelación de turnos	La flexibilidad del sistema y la liberación de espacios.	(Turnos cancelados con aviso / Total de turnos reservados) x 100.
% de ausentismo	Porcentaje de pacientes que no asisten.	(Turnos no asistidos / Total turnos) x 100
Tiempo promedio de asignación de turno	Cuánto demora una persona desde que ingresa al sistema y reserva su turno	Conteo del tiempo total desde el inicio de sesión hasta la confirmación
Cantidad de reclamos por turnos asignados	La precisión del nuevo sistema y la satisfacción del paciente.	Conteo mensual de quejas recibidas por la asignación de turnos

Justificación breve

Estos indicadores nos permiten ver si realmente estamos solucionando problemas de la clínica: los KPIs de ausentismo y cancelación nos dirán si los recordatorios automáticos funcionan. El tiempo de asignación medirá si el sistema es entendible para el paciente y fácil de usar. Y por último el conteo de reclamos será la prueba de que el sistema es confiable a la hora de usarlo.

7. Riesgos iniciales

Riesgo	Posible impacto	Acción preventiva o mitigación básica
Resistencia al cambio	Carga de datos incompleta o falta de uso del sistema, haciendo que la solución no sea efectiva.	Realizar capacitaciones cortas y mostrarles cómo el sistema les quitará trabajo administrativo pesado.

Dificultad de uso para pacientes mayores	Frustración de los usuarios y saturación del canal telefónico por dudas sobre el nuevo sistema.	Mantener una opción de asistencia guiada en recepción.
Fallas en la conexión a Internet	Imposibilidad de asignar turnos o consultar la agenda en tiempo real, paralizando la atención.	Contar con un plan de respaldo (back-up) diario de la agenda que se pueda consultar offline.
Datos previos incorrectos	Que los turnos que ya estaban anotados en papel se pisen con los nuevos del sistema digital.	Hacer una limpieza y revisión total de las planillas actuales antes de pasarlas a la nueva plataforma.

8. Cierre integrador

El proyecto propone la implementación de un Sistema de gestión de agenda y notificaciones automatizadas en la Clínica del Sur. La lógica central radica en reemplazar el proceso manual y descentralizado de asignación de turnos por una solución digital centralizada (aplicación web interna) que garantice la gestión en tiempo real de las agendas médicas. El valor fundamental es la optimización administrativa y la mejora de la experiencia del paciente a través de la eliminación de la superposición de turnos y la reducción significativa del ausentismo, lograda mediante el envío automático de recordatorios por canales digitales (WhatsApp, SMS, Email). El éxito del proyecto depende de la adopción del Personal Administrativo y la correcta integración de un *software funcional* que cumpla con los objetivos de eficiencia y confiabilidad, manteniendo el alcance enfocado exclusivamente en la gestión de turnos sin incluir, en esta etapa inicial, funcionalidades como historias clínicas o facturación.